幽门螺杆菌感染

知识类别：疾病与健康知识
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/digestive-disorders/gastritis-and-peptic-ulcer-disease/helicobacter-pylori-infection
获取日期：2026-10-19

以下为逐字转载的原文内容：

幽门螺杆菌 感染
（幽门螺旋杆菌感染）
幽门螺杆菌（H. pylori ）感染是一种细菌感染，可引起胃部炎症（ 胃炎 ）、 消化性溃疡病 和某些类型的 胃癌 。
症状 |
诊断 |
治疗 |
预后 |
感染是由一种称为 幽门螺杆菌 （ H. pylori ）的细菌引起的。
感染是由一种称为 幽门螺杆菌 （ H. pylori ）的细菌引起的。
幽门螺杆菌 感染的症状包括消化不良、上腹部疼痛或不适。
幽门螺杆菌 感染的症状包括消化不良、上腹部疼痛或不适。
医生根据呼吸试验或粪便检查的结果，或使用挠性观察导管的胃镜检查（上消化道内镜检查）结果进行诊断。
医生根据呼吸试验或粪便检查的结果，或使用挠性观察导管的胃镜检查（上消化道内镜检查）结果进行诊断。
治疗采用抗生素和一种质子泵抑制剂。
治疗采用抗生素和一种质子泵抑制剂。
（也可参见 胃炎和消化性溃疡病简介 。）
幽门螺杆菌 感染是全球 胃炎 和 消化性溃疡病 的最常见病因。感染十分常见，并随年龄增长而增多。感染最常见于黑人、西班牙人和亚洲人。
幽门螺杆菌 感染胃黏膜，也可见于粪便、唾液和牙菌斑中。 幽门螺杆菌 可在人与人之间传播，尤其是感染者便后未彻底洗手时。由于人也可以通过亲吻或其他亲密接触传播细菌，因此感染往往会在家庭中、在疗养院及其他受监管的护理机构中居住的人群中爆发。
您知道吗……
您知道吗……
某种称为 幽门螺杆菌 的细菌是胃炎和胃溃疡的最常见病因。
某种称为 幽门螺杆菌 的细菌是胃炎和胃溃疡的最常见病因。
某种称为 幽门螺杆菌 的细菌是胃炎和胃溃疡的最常见病因。
幽门螺杆菌 在胃壁的保护性粘膜层内生长，在那里它们很少暴露于胃的高酸环境中。此外， 幽门螺杆菌 可产生氨，帮助保护该细菌免遭胃酸侵蚀，并使其破坏和穿透黏液层。
幽门螺杆菌 感染的并发症
几乎所有 幽门螺杆菌 感染者都患有 胃炎 ，可累及全胃或仅累及胃下部（胃窦）。有时感染可引起糜烂性胃炎 ，甚至可能引起 胃溃疡 或 十二指肠溃疡 。

幽门螺杆菌 可增加胃酸生成，干扰胃部的正常抗胃酸机制并产生毒素，从而诱发溃疡形成。
长时间感染 幽门螺杆菌 可增加 胃癌 的风险。
幽门螺杆菌 感染的症状
在 幽门螺杆菌 感染引起胃炎的患者中，大多不会出现症状或并发症，如胃或十二指肠消化性溃疡。对于因 幽门螺杆菌 感染而出现症状的患者，其症状属于胃炎的典型症状，包括 消化不良 和上腹部疼痛或不适。
幽门螺杆菌 感染所致溃疡的症状与其他溃疡症状相似，包括上腹痛。
幽门螺杆菌 感染的诊断
呼气试验或大便检查
呼气试验或大便检查
有时需要上消化道内镜检查
有时需要上消化道内镜检查
呼气试验或大便检查可检出 幽门螺杆菌 。
有时，医生使用一根可视软管（内镜）进行 上消化道内镜检查 ，以采集胃黏膜样本（活检）。可使用多种方法对该样本进行 幽门螺杆菌 检测。
幽门螺杆菌 感染的治疗
抗生素和质子泵抑制剂
抗生素和质子泵抑制剂
治疗后，需进行检测以确认 幽门螺杆菌 感染已根除
治疗后，需进行检测以确认 幽门螺杆菌 感染已根除
幽门螺杆菌 感染的最常见疗法是联合使用可减少胃酸生成的一种 质子泵抑制剂 和两种抗生素，有时也联用次水杨酸铋。给予兰索拉唑、奥美拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑或埃索美拉唑数种质子泵抑制剂其中之一。这些药物通常耐受良好（副作用很少或轻微），但可能导致腹泻、便秘和头痛。也可使用数种不同的抗生素，包括阿莫西林、克拉霉素、甲硝唑和四环素。这些抗生素均可能改变味觉并导致恶心， 阿莫西林 、 克林霉素 和 四环素 可能导致腹泻。 次水杨酸铋 可能导致便秘，以及舌头和粪便发黑。
医生通常会在治疗结束后 4 周左右重做呼气试验、大便检查或内镜，以确认治疗成功。
如果 幽门螺杆菌 未根除，应重复治疗。
幽门螺杆菌 感染的预后
如果 幽门螺杆菌 感染完全根除，消化性溃疡在 3 年内复发的几率低于 10%。如果 幽门螺杆菌 感染未完全根除，消化性溃疡在 3 年内复发的几率高于 50%。另外，抗 幽门螺杆菌 的治疗可能会使此前治疗未治愈的溃疡愈合。